



FARMÁCIA DE MINAS
ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA SOLICITAÇÃO DE
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO

- ✓ O Sr(a). deverá providenciar todos os itens indicados na “Relação de documentos e exames para solicitação de medicamentos”.
- ✓ Observe que alguns deles devem ser preenchidos e assinados pelo seu médico:
 - Laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos (LME);
 - Prescrição médica;
 - Relatório médico e/ou Formulário Específico; e
 - Termo de Conhecimento de Risco (se houver) e/ou Termo de Esclarecimento e Responsabilidade (se houver).
- ✓ De posse de todos os documentos necessários, o Sr(a). ou seu representante deve dirigir-se à Coordenação de Assistência Farmacêutica (CAF) de sua regional de saúde, ou à farmácia de seu município.
- ✓ A SES-MG estima um prazo médio de 30 dias para avaliação de sua solicitação.
- ✓ Baixe o Aplicativo MG-App em seu celular e acompanhe a situação da análise de sua solicitação. Você também poderá acessar o Portal MG (<https://cidadao.mg.gov.br>).
- ✓ Em caso de dúvidas, procure o farmacêutico de sua regional ou de seu município.



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR (HAP)

Medicamentos com restrição de idade:

Ambrisentana - Idade mínima: 18 anos

DOCUMENTOS PESSOAIS A SEREM APRESENTADOS

- ☐ Cópia da Carteira de Identidade (ou Documento de Identificação com foto)
- ☐ Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
- ☐ Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS)
- ☐ Cópia do Comprovante de Residência

DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS PELO MÉDICO

→ SOLICITAÇÃO INICIAL	→ RENOVAÇÃO DO TRATAMENTO (A CADA 6 MESES)	→ REAVALIAÇÃO (TROCA OU INCLUSÃO DE NOVO MEDICAMENTO)
☐ LME - Laudo para Solicitação de Medicamentos do CEAF ☐ Prescrição Médica ☐ Formulário Específico: HAP	☐ LME - Laudo para Solicitação de Medicamentos do CEAF ☐ Prescrição Médica	☐ LME - Laudo para Solicitação de Medicamentos do CEAF ☐ Prescrição Médica ☐ Relatório Médico constando: • Justificativa para a troca; • Para inclusão de medicamento, incluir re-estratificação de risco.

EXAMES

→ SOLICITAÇÃO INICIAL: EXAMES GERAIS

- ☐ Cateterismo Cardíaco Direito com Teste Agudo de Reatividade Vascular com Óxido Nítrico (Último realizado)
- ☐ Laudo de Angiotomografia de tórax ou Laudo de Cintilografia Pulmonar de Perfusão (Último realizado)
- ☐ Teste de Caminhada de seis minutos (Último realizado)
- ☐ TGO/AST e TGP/ALT (Validade 3 meses)
- ☐ Hemograma com plaquetas (Validade 3 meses)

→ SOLICITAÇÃO INICIAL: EXAMES ESPECÍFICOS CONFORME MEDICAMENTO REQUERIDO**Para Ambrisentana, Bosentana, Iloprosta**

- ☐ β-HCG para mulheres em idade fértil (Validade 15 dias)

→ REAVALIAÇÃO (TROCA OU INCLUSÃO DE NOVO MEDICAMENTO): EXAMES ESPECÍFICOS CONFORME NOVO MEDICAMENTO REQUERIDO**Para Ambrisentana, Bosentana, Iloprosta**

- ☐ Teste de Caminhada de seis minutos (Último realizado)
- ☐ TGO/AST e TGP/ALT (Validade 3 meses)
- ☐ Hemograma com plaquetas (Validade 3 meses)
- ☐ β-HCG para mulheres em idade fértil (Validade 15 dias)

Para Sildenafil

- ☐ Teste de Caminhada de seis minutos (Último realizado)
- ☐ TGO/AST e TGP/ALT (Validade 3 meses)
- ☐ Hemograma com plaquetas (Validade 3 meses)

OBSERVAÇÕES PARA DISPENSAÇÃO

Não se aplica

DATA:

LOCAL:

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA





FORMULÁRIO ESPECÍFICO – HAP

1	NOME CIVIL DO(A) PACIENTE: _____ NOME SOCIAL DO(A) PACIENTE: _____
2	DATA DE NASCIMENTO: ____ / ____ / ____
3	CID-10: _____
4	4.1 HIPERTENSÃO PULMONAR – INDICAR GRUPO: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V 4.2 INFORMAR: Paciente possui fatores de risco ou dados ecocardiográficos compatíveis com doenças do coração esquerdo como causa de HP? SIM ☐ NÃO ☐ Paciente possui exames compatíveis com doenças pulmonares crônicas como causa de HP? SIM ☐ NÃO ☐ Paciente possui exames compatíveis com embolia pulmonar como causa de HP? SIM ☐ NÃO ☐
5	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EVOLUÇÃO DA DOENÇA: _____ _____ _____ _____ _____
6	CATETERISMO CARDÍACO DIREITO: Data: ____ / ____ / ____ ☐ PAPm: _____ ☐ POAP ou PDFVE: _____ ☐ RVP Wood: _____ PAPm: pressão arterial pulmonar média; POAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar; PDFVE: pressão diastólica final do ventrículo esquerdo; RVP: resistência vascular pulmonar
7	INFORMAR ETIOLOGIA DA DOENÇA: ☐ 7.1 HAP Idiopática, hereditária ou induzida por drogas. 7.1.1 Caso assinalado o item acima, indicar: TESTE DE REATIVIDADE COM ÓXIDO NÍTRICO: ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO Justificativa para não realização do teste: _____ OU ☐ 7.2 HAP associada 7.2.1 Caso assinalado o item acima, indicar enfermidade associada: ☐ Colagenoses, ☐ Hipertensão Porto-pulmonar ☐ Esquistossomose ☐ HIV ☐ Cardiopatia congênita ☐ Veno-oclusiva



8	MEDICAMENTOS SOLICITADOS: <table border="1"><thead><tr><th>Medicamentos solicitado</th><th>Posologia</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ Ambrisentana</td><td></td></tr><tr><td>☐ Bosentana</td><td></td></tr><tr><td>☐ Sildenafil</td><td></td></tr><tr><td>☐ Iloprosta</td><td></td></tr></tbody></table>	Medicamentos solicitado	Posologia	☐ Ambrisentana		☐ Bosentana		☐ Sildenafil		☐ Iloprosta						
Medicamentos solicitado	Posologia															
☐ Ambrisentana																
☐ Bosentana																
☐ Sildenafil																
☐ Iloprosta																
9	RISCO ESTRATIFICADO (CONFORME PCDT): ☐ RISCO BAIXO ☐ RISCO INTERMEDIÁRIO ☐ RISCO ALTO Detalhar: _____ _____ _____ _____ _____ _____															
10	CLASSE FUNCIONAL (NYHA/WHO-FC): ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV															
11	O PACIENTE APRESENTA ALGUMA DAS SITUAÇÕES DESCRITAS ABAIXO? <table border="1"><tbody><tr><td>Doença hepática grave</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr><tr><td>Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr></tbody></table>	Doença hepática grave	SIM ☐	NÃO ☐	Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar	SIM ☐	NÃO ☐	Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)	SIM ☐	NÃO ☐	Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia	SIM ☐	NÃO ☐	Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC	SIM ☐	NÃO ☐
Doença hepática grave	SIM ☐	NÃO ☐														
Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar	SIM ☐	NÃO ☐														
Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)	SIM ☐	NÃO ☐														
Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia	SIM ☐	NÃO ☐														
Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC	SIM ☐	NÃO ☐														



12	EXAMES COMPLEMENTARES:		
	Exames complementares	Data	Resultado
	Ecocardiograma		
	Eletrocardiograma		
	Espirometria		
	Teste de caminhada de 6 minutos (T6MC)		
	Polissonografia/Oximetria Noturna*		
	Angiotomografia de tórax ou Cintilografia Pulmonar de Perfusão		
	Ultrassonografia abdominal		
	Gasometria arterial		
	Radiografia de Tórax		
Nyha: new york heart association. Who: world health organization. Fc: functional classification * Reservado aos pacientes com sintomatologia da síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono (sahos).			
13	OUTRAS OBSERVAÇÕES PERTINENTES: 		
14	Assumo integral responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. Data de preenchimento: ____ / ____ / ____ Assinatura e carimbo: _____ Médico		



Sistema Único de Saúde
Ministério da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

CAMPOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO MÉDICO SOLICITANTE

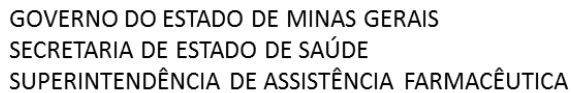
1- Número do CNES		2- Nome do estabelecimento de saúde solicitante					
3- Nome completo do Paciente*		5- Peso do paciente* kg					
4- Nome da Mãe do Paciente*		6- Altura do paciente* cm					
7- Medicamento(s)*		8- Quantidade solicitada*					
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1							
2							
3							
4							
5							
6							
9- CID-10*		10- Diagnóstico					
11- Anamnese*							
12- Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?*							
☐ NÃO ☐ SIM. Relatar:							
13- Atestado de capacidade* A solicitação do medicamento deverá ser realizada pelo paciente. Entretanto, fica dispensada a obrigatoriedade da presença física do paciente considerado incapaz de acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil. O paciente é considerado incapaz? ☐ NÃO ☐ SIM. Indicar o nome do responsável pelo paciente, o qual poderá realizar a solicitação do medicamento Nome do responsável							
14- Nome do médico solicitante*		17- Assinatura e carimbo do médico*					
15- Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do médico solicitante*		16- Data da solicitação*					

18 - CAMPOS ABAIXO PREENCHIDOS POR*: ☐ Paciente ☐ Mãe do paciente ☐ Responsável (descrito no item 13) ☐ Médico solicitante

☐ Outro, informar nome: _____ e CPF _____

19- Raça/Cor/Etnia informado pelo paciente ou responsável* ☐ Branca ☐ Amarela ☐ Preta ☐ Indígena. Informar Etnia: _____ ☐ Parda	20- Telefone(s) para contato do paciente
21- Número do documento do paciente ☐ CPF ou ☐ CNS	23- Assinatura do responsável pelo preenchimento*
22- Correio eletrônico do paciente	

*CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO



CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO PROFISSIONAL NA FARMÁCIA (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)	
UNIDADE SOLICITANTE (CAF OU MUNICÍPIO):	CAF DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO (SE HOUVER):
NOME CIVIL COMPLETO DO(A) PACIENTE SOLICITANTE:	
NOME SOCIAL COMPLETO DO(A) PACIENTE SOLICITANTE:	
CPF:	TELEFONE(S) PARA CONTATO:
MEDICAMENTO(S) SOLICITADO(S):	
DATA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: _____ / _____ / _____	
NÚMERO DO PROCESSO SEI: (OBSERVAÇÃO: PARA PACIENTES JÁ CADASTRADOS NO PROGRAMA, OS NOVOS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVEM SER SEMPRE INSERIDOS NO PROCESSO SEI EXISTENTE, CASO REFERENTES À MESMA CONDIÇÃO CLÍNICA/CHECKLIST)	
NÚMERO DO PROCESSO SIGAF:	
OBSERVAÇÕES:	
NOME LEGÍVEL DO(A) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DO REQUERIMENTO DE MEDICAMENTOS DO CEAF	

Eu _____ declaro que li e concordo com todas as informações apresentadas no Termo de Adesão sobre a solicitação de medicamentos do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica.

ASSINATURA DO(A) PACIENTE OU RESPONSÁVEL



TERMO DE ADESÃO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CEAF

Esse documento tem por objetivo registrar a entrega dos documentos para a solicitação de medicamentos e traz algumas informações úteis ao paciente

O que esse documento indica?

Que seu pedido por um medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica foi registrado.

Quais são os próximos passos?

Seus documentos serão analisados pela equipe de analistas da Secretaria de Saúde de Minas Gerais com base no definido em regras estaduais e federais (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, Portarias e Resoluções Estaduais).

Após isso, um documento será produzido com a resposta ao seu pedido, que poderá ser:

- **DEFERIDO:** não existiam erros no seu pedido e por isso ele foi aceito. Será possível iniciar o tratamento, desde que tenha disponibilidade do medicamento na farmácia.
- **DEVOLVIDO:** faltam exames, documentos ou informações no seu pedido e por isso ele precisa ser completado. É preciso que os documentos faltantes sejam entregues em até 90 dias.
- **INDEFERIDO:** seu pedido não obedece às regras estaduais e federais para conseguir o medicamento. Veja o motivo do indeferimento na resposta e leve o documento ao médico.

Como saber o resultado do meu pedido?

Você pode descobrir o resultado pelo MG APP. Para isso, faça o cadastro no aplicativo, acesse o menu, em seguida vá em “Saúde”, depois “Consulta do Andamento da Solicitação de Medicamentos”. Então insira seus dados e selecione o medicamento que gostaria de consultar.

E em caso de dúvidas?

Em caso de dúvidas, acesse a página www.saude.mg.gov.br/obtermedicamentosceaf.

Se o pedido for DEFERIDO, o que mais preciso saber?

- A cada 180 dias (6 meses) é necessário entregar novo Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de medicamentos (LME) e nova receita médica para garantir a continuidade do tratamento;
- Caso o pedido pelo medicamento precise de reavaliação periódica, é necessário entregar novas documentações (LME, receita médica e outros documentos) à farmácia, de tempos em tempos, para continuidade do tratamento. Caso os novos documentos não sejam entregues, o fornecimento do medicamento poderá ser interrompido;
- Para medicamentos sujeitos a controle especial, será necessário entregar nova receita médica mensalmente;
- Caso o medicamento não seja retirado por 6 meses contínuos, sem uma explicação médica anterior a paralisação, será considerado que houve interrupção ou abandono de tratamento e o pedido será INATIVADO. Nesses casos, para conseguir novamente o medicamento, o paciente deverá fazer um novo pedido;
- Caso o tratamento precise ser paralisado por questões médicas, é necessário entregar relatório médico com o motivo da suspensão antes da próxima data de retirada do medicamento. Além disso, quando for necessário reiniciar o tratamento, será preciso entregar nova LME e receita médica;
- Caso o paciente não possa comparecer à farmácia para retirar o medicamento, deverá indicar os representantes por meio da Declaração Autorizadora.

Todos os documentos relativos às solicitações de medicamento(s), uma vez feito o pedido, passam a pertencer à Secretaria Estadual de Saúde. Caso necessário, o usuário/representante poderá solicitar cópias deles.

REGISTRO DA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO

Nome civil do paciente:			
Nome social do paciente:			
Data da solicitação:	/	/	Nº do Processo SIGAF:
Medicamentos solicitados:			
Observações:			
Assinatura do(a) profissional responsável pelo recebimento da solicitação			